

表 2 单用氨茶碱(I)及合并地尔硫草(II)后茶碱血药浓度(μg/ml)

编号	10min		30min		60min		120min		180min		240min	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	18.09	28.33	16.59	22.95	15.36	21.01	14.23	18.28	11.25	17.42	7.27	14.45
2	17.04	29.42	15.33	21.35	14.05	19.19	12.32	15.14	10.22	11.37	6.14	9.09
3	23.36	26.09	21.15	21.73	18.10	14.75	13.99	13.07	11.50	12.16	9.14	10.64
4	23.68	24.69	20.56	23.47	19.21	21.51	16.94	15.82	14.45	13.80	11.66	11.33
5	23.38	28.51	19.17	23.17	14.35	19.52	13.31	16.81	13.08	14.60	11.87	12.20
6	23.58	28.84	19.07	21.20	17.69	20.21	14.84	19.58	14.84	14.39	11.01	10.85
$\bar{x}$	21.5	28.2	18.6	21.6	16.1	18.9	14.8	16.8	12.6	14.3	9.5	11.9
$\pm s$	3.1	2.5	2.3	1.6	2.1	2.6	2.1	2.2	1.7	1.9	2.4	1.8

表 3 单用氨茶碱(I)及合用地尔硫草(II)的药动学参数

编号	K(h ⁻¹)		T _{1/2} (h)		V(L)		AUC(μg/ml·h)	
	I	II	I	II	I	II	I	II
1	0.192	0.151	3.609	4.578	2.192	1.587	53.58	77.70
2	0.212	0.300	3.272	2.308	1.991	1.507	48.22	63.83
3	0.242	0.262	2.861	2.646	1.851	1.431	60.24	59.37
4	0.169	0.210	4.106	3.309	1.446	1.702	68.09	69.42
5	0.154	0.220	4.497	3.148	2.894	2.217	58.88	71.32
6	0.169	0.216	4.111	3.233	2.832	2.338	64.94	72.94
$\bar{x}$	0.19	0.22	3.7	3.2	2.2	1.8	60	69*
$\pm s$	0.03	0.05	0.6	0.8	0.6	0.4	7	6

* $P<0.05$

疗有影响,仅对哮喘患者或正常受试者的血清茶碱浓度稍有上升或无影响^[6],这与本文结果相一致。

4.2 本文统计结果表明,单用氨茶碱及氨茶碱与地尔硫草合用后,两组的药物动力学参数K、T_{1/2}、V均无显著性差异($P>0.05$),仅AUC后者比前者有显著性差异($P<0.05$),表

明地尔硫草对氨茶碱药动学性质未发生显著影响。提示合并用药时不需要调整氨茶碱的剂量,但要注意监测茶碱血药浓度。

参 考 文 献

1 Tateishi T. Effect of cimetidine and diltiazem for metabolize of propranolol. J Clin Pharmacol, 1992, 32(12): 1099
2 陈刚主编. TDM 的理论与实践. 南京军区总医院药理科. 1985, 244
3 Nafziger AN, May JJ, Bertino JS. Inhibition of theophylline elimination by diltiazem therapy. J Clin Pharmacol, 1987, 27: 862
4 Abernethy DR, Egan JM, Dickinson TH, et al. Substrate-selective inhibition by verapamil and diltiazem: differential disposition of antipyrine and theophylline in humans. J Pharmacol Exp Ther, 1988, 244: 994
5 Abernethy DR, Egan JM, Carrum G. Calcium antagonists inhibit oxidative drug biotransformation. Clin Res, 1986, 34: 394A
6 陈世铭, 张志萍, 刘 屏等主编. 药物不良相互作用的临床意义与处理. 北京: 中国科学技术出版社. 1993. 467
(1993 年 12 月 27 日收稿)

吡二丙胺的药物相互作用

徐永昭 (辽宁省大连医科大学附属第一医院 116011)

吡二丙胺是一种新型抗心律失常药。现将其与下列二十种药物联合用药情况介绍如下:

地高辛: 吡二丙胺具有房室区不应期缩短的阿托品样作用, 而地高辛是通过延长房室区的不应期, 减慢传导而达到在房速时对心室的保护作用。二者合用时, 使后者失去对心肌的保护作用, 有引起心室率增加的潜在危险。

氨吡酮: 二者合用时可致严重的低血压,

应慎重。

奎尼丁: 二者合用毒性增加。单用吡二丙胺无效的心律失常患者, 可合用奎尼丁, 但要注意引起负性肌力作用和心脏传导延缓。

普鲁卡因胺: 二者合用可引起负性肌力作用和心脏传导延缓。对单用吡二丙胺无效的患者, 可合用普鲁卡因胺, 但应慎重。

利多卡因: 吡二丙胺有 Q-T 间期延长的

作用，利多卡因对窦房结和传导系统有加快复极作用，表现为 Q—T 间期缩短。二者合用对治疗顽固性室性心律失常者疗效较好。

胺碘酮：二者合用时，Q—T 间期延长，可致扭转型室速，不宜合用，如必须同服，则吡二丙胺剂量应减少 50%^[1]。

美西律：二者合用具有协同作用，对顽固性的心律失常效果良好。

托卡胺：二者合用对室性心律失常者效果良好。

普罗帕酮：二者均具有负性肌力作用增加，合用时 Q—T 间期延长，出现扭转室速、心脏传导阻滞、心脏停搏，故不宜合用^[2]。

恩卡胺：二者均具有负性肌力作用，合用危险性大，故一般不宜合用。

氯卡胺：二者均具有负性肌力作用，合用时可致传导阻滞，心脏停搏，应慎重^[3]。

氟卡胺：二者合用时负性肌力增加，危险性增大，不宜合用^[3]。

维拉帕米：二者均可引起房室传导阻滞和负性肌力作用，合用无益处，只能产生更多的危险，应禁止合用^[4]。

硝苯地平：二者合用可致房室传导阻滞、增加负性肌力作用，合用是危险的。

地尔硫草：二者合用呈协同的负性肌力作

用，危险性增加，一般应禁止合用^[4]。

普萘洛尔：二者合用负性肌力增强，加重窦性心动过缓和传导阻滞，甚至停搏，引起死亡。应慎用或禁用。

美多洛尔：二者呈协同的负性肌力作用，加重窦性心动过缓和传导阻滞，严重可致心跳停搏。

肝药酶诱导剂：苯妥英钠、利福平、苯巴比妥等均为很强的肝药酶诱导剂，可加速吡二丙胺在肝脏中的代谢，降低其疗效。

抗胆碱能药：三环抗抑郁药、抗组胺药、抗震颤麻痹药、止吐药、吩噻嗪类等具抗胆碱能作用，能增加吡二丙胺的副作用，合用是不恰当的。

华法林：吡二丙胺能增加华法林的抗凝作用，合用时应注意。

参 考 文 献

1 徐永昭. 乙胺碘呋酮与其他药物的相互作用. 中国急救医学, 1987, 7(1): 45
2 徐永昭. 普罗帕酮的药物相互作用. 临床医学杂志, 1989, 5(6): 316
3 俞 兵. 联合用药在心律失常治疗中的作用. 心血管病学进展, 1989, 10(2): 51
4 徐永昭. 钙拮抗剂的药物相互作用. 医师进修杂志, 1988, 11(7): 1

(1993 年 10 月 15 日收稿)

聚糖铁复合物治疗儿童贫血疗效观察

张 峰 刘纪平 林小军 刘春阳 胡仪吉 (北京市儿童医院 100045)

张秉尧 于爱林 刘 满 王贵芹 (河北省固安县医院)

缺铁性贫血(IDA)是世界范围内最常见的营养性疾病之一。在我国发病率也较高，据国内调查资料表明：儿童的贫血率高达 30% 左右。而防治 IDA 除改善饮食外，最根本的方法是给机体补充足量的铁。但选择吸收好而副作用低的铁剂是儿科医师十分关心的事。

我院与固安县医院儿科于 1994. 4~1994. 5 应用聚糖铁复合物(商品名为 Niferex，化学

名 Polysaccharide-Iron Complex，简称为 PIC。该药是由美国中央大药厂研制的口服补铁溶液，是一种低分子多糖和铁的有机复合物)。治疗小儿 IDA，以观察该药在 IDA 治疗中的疗效，确定其推广应用的价值。

1 方法及对象

1.1 观察对象 在河北固安县三个村对 5 个月~3 岁儿童进行贫血筛查，对 Hb<110g/L

中国医院药学杂志 1995 年第 15 卷第 2 期